

SÍNCOPE NO CARDIOGÉNICO

Marta Espina San José, Blanca Heras Pozas.

INTRODUCCIÓN

Síncope no cardiogénico: pérdida brusca de conciencia y tono muscular de inicio brusco, durante segundos o pocos minutos, con recuperación espontánea; causada por hipoperfusión cerebral global transitoria de inicio rápido de origen no cardíaco.

Causas más frecuentes de síncope:

- Por reflejo neuromediado: (más frecuente, en jóvenes)
- Vasovagal (más frecuente): por distrés emocional u ortostático.*
- Situacional: postprandial, postejercicio, reflejo tusígeno/miccional/defecatorio.*
- Hipersensibilidad del seno carotídeo

Por ortostatismo (mayores): secundario a fármacos (diuréticos, vasodilatadores, antidepresivos, alcohol...); alteraciones autonómicas primarias (Parkinson, demencia) o secundarias (diabetes, uremia, amiloidosis.); por deplección de volumen.

Neurológico: vascular (isquemia, hemorragia subaracnoidea, síndrome de robo de la subclavia, migraña basilar), crisis comicial.

Psicógeno: hiperventilación, trastorno de conversión.

DIAGNÓSTICO

1º. Evaluación inicial

Anamnesis al paciente y a testigos: incluir postura en la que ocurrió, si se realizaba durante o después de ejercicio, asociado a algún desencadenante, si asociado a pródromos previo o a otra clínica concomitante (palpitaciones, dolor torácico, déficit neurológico), tiempo en comenzar y recuperar. Siempre incluir antecedentes personales y **medicación** del paciente.

Exploración física completa: especial hincapié a exploración cardiovascular y neurológica.

Electrocardiograma: descarta posibles causas de origen cardíaco.

Glucemia.

Analítica: hemograma, bioquímica, coagulación Solicitar troponina y Dímero D si sospecha de cardiopatía isquémica, TEP...*

Con todo ello:

- Se descarta una pérdida transitoria del conocimiento no sincopal (inicio no brusco y/o mayor duración y/o recuperación del conocimiento espontánea completa).
- Se orienta probable etiología.
- Se descarta causa que amenacen la vida (cardíaca, hemorrágica, tromboembolismo pulmonar, hemorragia subaracnoidea).

2º. Si causa de perfil de bajo riesgo: neuromediado, hipersensibilidad del seno carotídeo, ortostatismo (incluido asociado a fármacos), para confirmar sospecha se puede realizar:

- Test de ortostatismo: PA en decúbito y después de permanecer el paciente 1 min en bipedestación: si diferencia PAS mayor a 20 mmHg es significativo.
- Maniobras de Valsalva.
- Mesa basculante (Test de Tilt)
- Masaje de seno carotideo. Monitorización cardíaca con electrocardiograma y presión arterial tras masajear el seno carotideo.

El resto de pruebas analíticas o de imagen estarían orientadas según sospecha etiológica fundada.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Su tratamiento será específico de la causa del síncope.

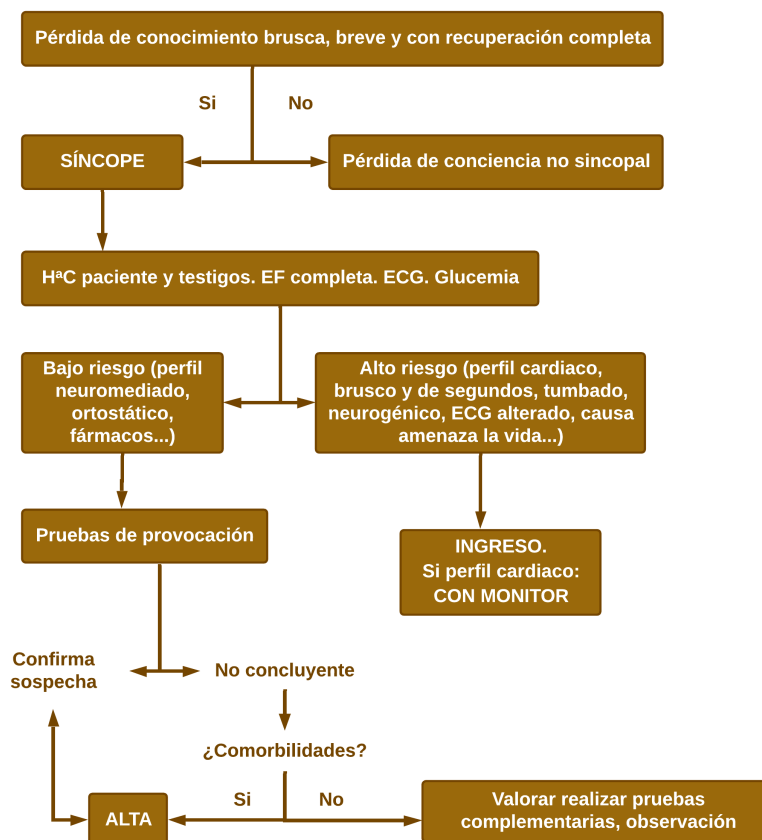
Si paciente con evento único, sin comorbilidades y con pruebas realizadas no alteradas podrá ser dado de alta.

CRITERIOS DE INGRESO:

- Síncope de perfil cardíaco, de alto riesgo: palpitaciones, dolor torácico, con cardiopatía, exploración física anormal, electrocardiograma normal, síncope brusco de segundos de duración, en decúbito o sentado, durante el ejercicio. INGRESAR CON MONITOR
- Síncope recidivante.
- Síncope de causa neurológica demostrada.

¡Alerta! No Olvidar En Urgencias:

- Lo más importante es realizar buena anamnesis al paciente y a los testigos, completa exploración física y realizar ECG.
- Realizar prueba de ortostatismo.
- Si no esclarecida la causa, se descarta perfil alto riesgo, no comorbilidades: alta.



BIBLIOGRAFÍA

- 2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the Evaluation and Management of Patients With Syncope. American College of Cardiology Foundation, the American Heart Association, Inc., and the Heart Rhythm Society. Publicado August 1, 2017. Volume 70, Issue 5. Páginas e39-e110
- Evaluation of Syncope in Older Adults. Teresita M. Hogan, et al. Emerg Med Clin N Am 34 (2016) 601–627
- Syncope in adults: Epidemiology, pathogenesis, and etiologies. Uptodate.
- Syncope. Shamai A. Grossman¹; William G. Gossman². StatPearls